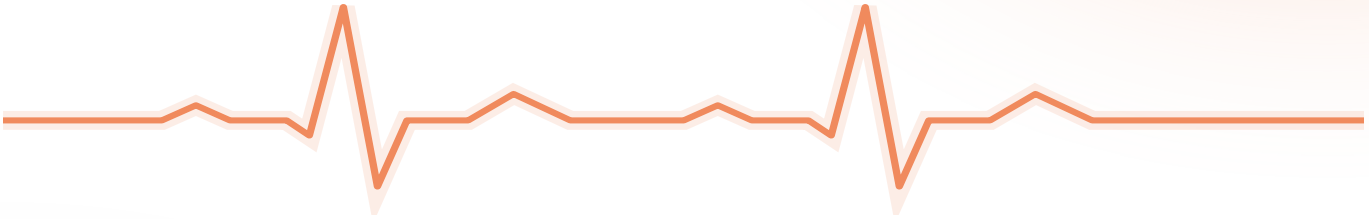
AranduMed

RESUMEN GRATUITO

MEDICINA INTERNA · VOL. 1

Cardiología

Lo que más pregunta el CONAREM



Las 46 preguntas de Cardiología de 2016 a 2026, convertidas en un resumen: qué se pregunta, cómo lo pregunta el examen, qué dicen las guías actuales y preguntas reales para practicar.

- Arritmias y ECG
- Insuficiencia cardíaca
- Vasos, TEP y shock
- Válvulas y miocardio
- Cardiopatía isquémica
- Hipertensión arterial
- Pericardio

Probá AranduMed 3 días gratis → tocá acá

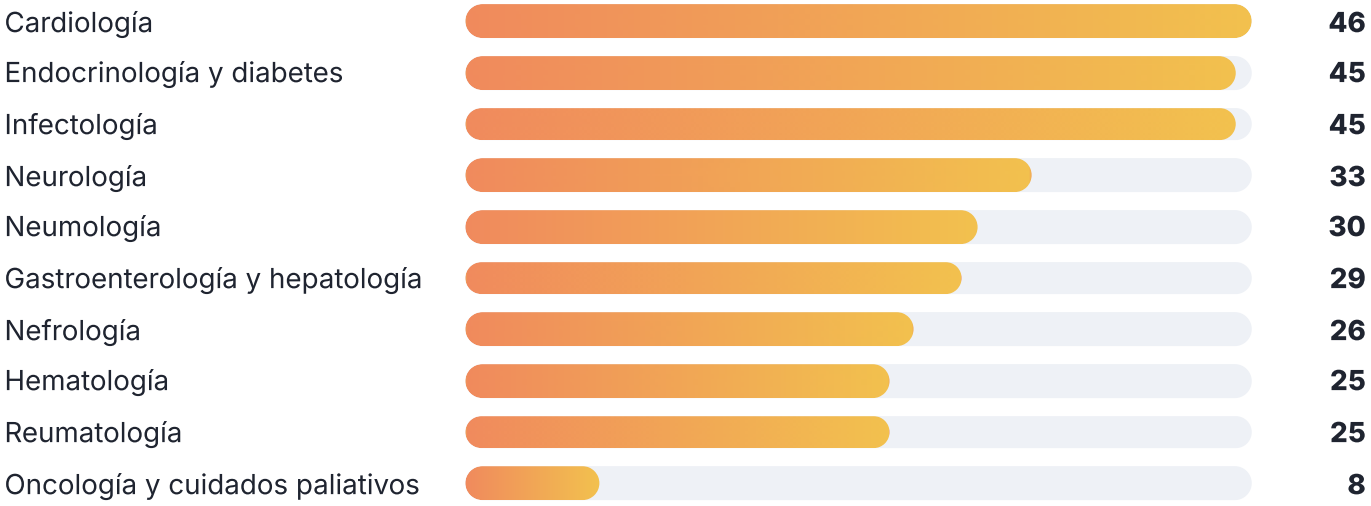
46	11	7	21
preguntas analizadas	exámenes 2016 – 2026	temas desarrollados	preguntas reales con su clave

AranduMed es un recurso independiente, sin vínculo oficial con el INS ni con la CONAREM.

ANTES DE EMPEZAR

Dónde se concentran las preguntas

De las 313 preguntas de Medicina Interna de 2016 a 2026, así se reparten. **Las tres primeras suman más del 40 %.**



CÓMO USAR ESTE CUADERNILLO

Sección	Para qué sirve
Desarrollo del tema	Lo que hay que saber, con tablas y esquemas
📝 **Cómo lo pregunta el CONAREM**	El formato real de la pregunta y sus trampas, debajo de cada subtema
⚠️ **Trampa** y 💡 **Para recordar**	Los distractores frecuentes y reglas para memorizar
Guías actuales vs. CONAREM	Qué dicen las guías más recientes, qué espera el examen y qué marcar
🧠 **Ponete a prueba**	3 preguntas reales por tema; la clave está en la matriz del final

Desarrollamos completa la subespecialidad **más preguntada: Cardiología**, con sus 46 preguntas. Las otras 9 tienen una vista previa al final.

CAPÍTULO 1 · 46 PREGUNTAS

Cardiología

La subespecialidad más preguntada de Medicina Interna: salió en **los 11 exámenes** de 2016 a 2026. Los temas van de más a menos preguntado.

1.1 Arritmias y electrocardiograma

Es el tema con más preguntas de Cardiología: **10 entre 2016 y 2026**, en 8 exámenes distintos. Hay dos grandes bloques: el **ECG «de memoria»** (qué es cada onda, qué patrón corresponde a qué enfermedad) y el **manejo** de arritmias concretas: fibrilación auricular, QT largo e hiperpotasemia.

1.1.1 EL ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL

El ECG es **el método diagnóstico de las arritmias**. El ecocardiograma muestra la estructura, pero no el ritmo. Conviene tener claro qué representa cada parte del trazado, porque las preguntas teóricas cambian una palabra («despolarización» por «repolarización») o un número.

Segmento	Qué representa	Valor normal
Onda P	Despolarización auricular	< 0,12 s y < 2,5 mm
Intervalo PR	Conducción aurícula → ventrículo	0,12 – 0,20 s
QRS	Despolarización ventricular	< 0,12 s (120 ms)
Punto J	Unión del final del QRS con el inicio del ST	Isoeléctrico
ST y onda T	Repolarización ventricular	ST isoeléctrico
QT corregido	Despolarización + repolarización ventricular	Prolongado si > 450 ms (♂) o > 460 ms (♀)
Onda U	Pequeña onda **después** de la T	Se agranda en la hipopotasemia

Crecimiento auricular	Cómo se ve la onda P
Izquierdo (estenosis mitral, HTA)	Ancha (≥ 0,12 s) y bífida en DII; en V1, **bifásica con componente negativo ancho**
Derecho (EPOC, hipertensión pulmonar)	Alta y picuda: > 2,5 mm en DII («P pulmonar»)

💡 **PARA RECORDAR:** el lado izquierdo «se ensancha» y el derecho «crece hacia arriba». P ancha = aurícula izquierda; P alta = aurícula derecha.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** preguntas de definición del tipo «respecto a un ECG normal, es correcto...» (2020) o «una onda P bifásica en V1 se observa en...» (2017). Los distractores dan vuelta conceptos: el QRS como «repolarización», la onda P como «repolarización auricular», un QRS normal de «120–200 ms» o la onda U «antes» de la T.

1.1.2 ANTIARRÍTMICOS: LA CLASIFICACIÓN DE VAUGHAN WILLIAMS

Clase	Mecanismo	Fármacos
Ia	Bloqueo de sodio (moderado)	Quinidina, procainamida
Ib	Bloqueo de sodio (débil)	Lidocaína, mexiletina
Ic	Bloqueo de sodio (potente)	**Flecainida, propafenona**
II	Bloqueo β-adrenérgico	**Betabloqueantes**
III	Bloqueo de potasio	**Amiodarona**, sotalol, dronedarona
IV	Bloqueo de calcio	Verapamilo, diltiazem

💡 **PARA RECORDAR:** el orden es **Sodio · Beta · Potasio · Calcio**: «**S**iempre **B**uscá **P**rimero el **C**orazón».

En el paciente con **cardiopatía estructural** (infarto previo, FE baja) que tiene arritmias ventriculares y no puede recibir un cardiodesfibrilador, el fármaco de elección es la **amiodarona**. Los de clase Ic (flecainida, propafenona) están **contraindicados** en la cardiopatía estructural porque aumentan la mortalidad.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** preguntas de **una línea**: «la propafenona es de clase...» (2018) y «los betabloqueantes son de clase...» (2016). En el formato de caso (2019) ponen como distractores fármacos que tratan otras arritmias: adenosina (taquicardia supraventricular), verapamilo, sotalol y **propafenona**, prohibida justamente en el cardiópata.

1.1.3 PREEXCITACIÓN: WOLFF-PARKINSON-WHITE

Una vía accesoria conecta aurícula y ventrículo sin pasar por el nodo AV, así que el ventrículo se activa antes. La tríada del ECG es **PR corto (< 0,12 s), onda delta** (el empastamiento inicial del QRS) y **QRS ancho**.

⚠️ **TRAMPA:** si un WPW hace **fibrilación auricular**, no se dan fármacos que frenan el nodo AV (adenosina, verapamilo, diltiazem, digoxina, betabloqueantes): todo el impulso pasa por la vía accesoria y puede degenerar en fibrilación ventricular. Si está inestable, cardioversión eléctrica; si está estable, procainamida. El tratamiento definitivo es la **ablación** de la vía.

> 📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** te describen el ECG con palabras («PR corto, onda delta y QRS prolongado», 2023) y tenés que ponerle nombre. Los distractores son otros ritmos que también alteran el PR o el QRS: ritmo de la unión, flutter auricular, taquicardia ventricular.

1.1.4 FIBRILACIÓN AURICULAR

Es la arritmia sostenida más frecuente. El trombo se forma en la **orejuela izquierda**, y de ahí el riesgo de ACV. Por eso el manejo tiene dos ejes: **control de frecuencia o ritmo** y **prevención de embolias**.

Escala	Qué mide	Componentes
CHA_2DS_2-VASc	Riesgo de **ACV** → decide anticoagular	IC, HTA, edad ≥ 75 (2 puntos), diabetes, ACV/AIT (2 puntos), enfermedad vascular, edad 65–74, sexo femenino
HAS-BLED	Riesgo de **sangrado**	HTA, función renal o hepática alterada, ACV, sangrado, INR lábil, edad > 65, fármacos o alcohol

FA de > 48 h o de inicio desconocido → **Anticoagular 3 semanas antes o descartar trombo con eco transesofágico** → **Cardioversión** → **Anticoagular 4 semanas después**

Para anticoagular se prefieren los **anticoagulantes orales directos** (apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán), salvo en dos situaciones donde solo sirven los antagonistas de la vitamina K (warfarina, acenocumarol): **válvula mecánica** y **estenosis mitral moderada a grave**.

> 📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** formato de «es correcto afirmar» con cuatro afirmaciones sobre FA (2024), donde las falsas cambian un detalle: la orejuela «derecha», el dabigatrán «recomendado» en la estenosis mitral o la válvula mecánica, y el CHA_2DS_2-VASc para estimar «sangrados». La correcta fue el riesgo de embolia al cardiovertir una FA de más de 48 horas.

1.1.5 QT LARGO Y TORSADES DE POINTES

El QT prolongado favorece la **torsades de pointes** (en francés, «torsión de las puntas»): una taquicardia ventricular polimorfa cuyos QRS giran alrededor de la línea de base y que puede degenerar en fibrilación ventricular. Puede ser **congénito** (canalopatías) o **adquirido**.

Causas adquiridas de QT largo	Ejemplos
Fármacos	Macrólidos, quinolonas, antipsicóticos, ondansetrón, metadona, amiodarona, sotalol
Electrolitos	Hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia
Otras	Bradicardia extrema, hipotiroidismo, hipotermia

Situación	Conducta
Torsades en curso, estable	**Sulfato de magnesio** 2 g IV; corregir potasio y suspender el fármaco
Torsades sin pulso o inestable	Desfibrilación
QT largo congénito	**Betabloqueante** (nadolol, propranolol) a todos
Congénito con síncope o paro recuperado	**Cardiodesfibrilador implantable**

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** un caso completo (2026): mujer joven con **síncope durante el ejercicio**, QTc de 520 ms y un hermano con muerte súbita. Piden **mecanismo y tratamiento en la misma opción**, así que hay que acertar los dos: torsades que degenera en fibrilación ventricular y cardiodesfibrilador. Las otras opciones combinan una arritmia incorrecta con un tratamiento plausible.

1.1.6 HIPERPOTASEMIA EN EL ELECTROCARDIOGRAMA

T picudas → **PR largo, P aplanada** → **QRS ancho** → **Onda sinusoidal → FV**

Paso	Para qué	Cómo
1. Estabilizar	Proteger la membrana del miocardio	**Gluconato de calcio 10 % IV en 10 minutos**; se repite si el ECG no mejora
2. Redistribuir	Meter el potasio en la célula	Insulina con glucosa, salbutamol nebulizado, bicarbonato si hay acidosis
3. Eliminar	Sacarlo del cuerpo	Diuréticos de asa, resinas de intercambio, diálisis

💡 **PARA RECORDAR:** el calcio **no baja el potasio**: solo gana tiempo. Por eso es lo primero cuando el ECG ya está alterado.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** caso de un renal crónico con palpitaciones, T picudas, QRS ancho y potasio de 7,2 (2018), y preguntan la **primera medida para estabilizar el ritmo**. Las trampas son medidas correctas pero de segundo paso (insulina con dextrosa, bicarbonato) o antiarrítmicos que no corresponden (amiodarona, lidocaína). En Nefrología (2020) volvieron a preguntar el calcio IV.

1.1.7 GUÍAS ACTUALES VS. CONAREM

🔬 Lo más actualizado	📝 Lo que refleja el CONAREM	✅ Qué marcar
Las guías europeas de 2024 reemplazaron el CHA_2DS_2-VASc por el **CHA_2DS_2-VA**: sacaron el sexo femenino como factor de riesgo.	Sigue usando el **CHA_2DS_2-VASc**, y lo pregunta para diferenciarlo del riesgo de sangrado.	CHA_2DS_2-VASc = riesgo de ACV; HAS-BLED = riesgo de sangrado.
En el QT largo congénito, el **betabloqueante es la base** del tratamiento; el cardiodesfibrilador se agrega con síncope o paro recuperado.	Presenta un caso con síncope y muerte súbita familiar.	Con síncope en el caso: **cardiodesfibrilador**.
El WPW sintomático se cura con **ablación** de la vía accesoria.	Pregunta sobre todo el **reconocimiento del ECG**.	PR corto + onda delta + QRS ancho = WPW.

🧠 PONETE A PRUEBA · ARRITMIAS Y ECG

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2023 · ▮▯▯ Básica · Cardiología · 2023B2-11

1. Electrocardiograma que muestra un intervalo PR corto, onda delta y una prolongación del QRS hace pensar en:

A) Ritmo de la unión
B) Taquicardia sinusal inapropiada
C) Síndrome de Wolff Parkinson White
D) Fluter auricular
E) Taquicardia ventricular

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2024 · ▮▮▯ Intermedia · Cardiología · 2024B2-09

2. Entre las siguientes aseveraciones en relación a la fibrilación auricular, es correcto afirmar:

A) La principal fuente de tromboembolia y ataque cerebrovascular en la fibrilación auricular, es la formación de trombos en la orejuela derecha
B) El dabigatram es el fármaco que se recomienda para pacientes con estenosis mitral reumática o válvulas cardiacas mecánicas
C) El puntaje en la escala de CHA2DS2-VASc, se emplea para estimar el riesgo de sangrados
D) Cuando la fibrilación auricular es mayor a 48 horas, y en pacientes con alto riesgo de tromboembolia, la conversión a ritmo sinusal se asocia con un riesgo aumentado de tromboembolismo

MEDICINA INTERNA | CONAREM 2026 | Intermedia | Cardiología | 2026B1-36

3. **Mujer de 41 años, sin antecedentes cardiovasculares previos presenta síncope durante el ejercicio. ECG en reposo: intervalo QT corregido de 520 ms. Su hermano falleció súbitamente a los 35 años. ¿Cuál es el mecanismo arrítmico en esta condición y su tratamiento de elección?**

A) Taquicardia ventricular monomórfica sostenida; amiodarona IV
B) Torsades de pointes degenerada en fibrilación ventricular; cardiodesfibrilador implantable
C) Fibrilación auricular con conducción aberrante; ablación con catéter

1.2 Insuficiencia cardíaca

El segundo tema más preguntado de Cardiología: **9 preguntas entre 2017 y 2026**. El examen insiste en cómo se confirma el diagnóstico cuando la clínica no alcanza, **qué fármacos cambian la mortalidad** y cuáles solo alivian.

1.2.1 CLASIFICACIÓN

Se clasifica de tres maneras: por la **fracción de eyección** (define el tratamiento), por los **síntomas** (NYHA) y por el **estadio** de la enfermedad (A a D).



NYHA	Síntomas	Estadio	Qué significa
I	Sin síntomas con la actividad habitual	**A · riesgo**	HTA, diabetes, cardiotóxicos; corazón sano
II	Disnea con esfuerzos habituales	**B · daño**	Cardiopatía estructural sin síntomas
III	Disnea con esfuerzos menores	**C · síntomas**	Cardiopatía estructural con síntomas
IV	Síntomas en reposo	**D · refractaria**	Necesita inotrópicos, asistencia o trasplante

💡 **PARA RECORDAR:** NYHA habla de **cómo se siente hoy** el paciente y puede mejorar con el tratamiento; el estadio habla de **hasta dónde llegó la enfermedad** y nunca retrocede.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** hasta ahora nunca preguntó la clasificación sola. La usa **dentro del enunciado** («FE disminuida», «FE conservada») como pista para que elijas el tratamiento o la causa.

1.2.2 DIAGNÓSTICO: LOS PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS

El ventrículo estirado libera **BNP y NT-proBNP**. Su mayor valor es **negativo**: un resultado normal hace muy improbable la insuficiencia cardíaca en el paciente con disnea. Se piden cuando la clínica es dudosa.

	Descarta en el paciente ambulatorio	Descarta en la disnea aguda
BNP	< 35 pg/mL	< 100 pg/mL
NT-proBNP	< 125 pg/mL	< 300 pg/mL

⚠️ **TRAMPA:** suben también sin insuficiencia cardíaca en la **falla renal**, la edad avanzada, la fibrilación auricular, el TEP y la sepsis. **Bajan en la obesidad**: un obeso puede tener valores «normales» con insuficiencia cardíaca.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** preguntas **cortas y directas**, sin caso clínico: «¿cuáles son los biomarcadores más utilizados...?» (2020, 2025 🔁) o «se incrementan falsamente en...» (2017). Los distractores son otros marcadores conocidos: **troponina, CK-MB y dímero D**.

1.2.3 TRATAMIENTO DE LA FE REDUCIDA

La pregunta clásica es **qué baja la mortalidad**. La respuesta son cuatro grupos que bloquean la activación neurohormonal o protegen el corazón y el riñón. Todo lo demás alivia síntomas o se suma en casos puntuales.

Bajan la mortalidad →

- **Sacubitrilo-valsartán** (o IECA / ARA II)
- **Betabloqueante** bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinato
- **Antagonista mineralocorticoide** espironolactona, eplerenona
- **iSGLT2** dapagliflozina, empagliflozina

Diuréticos de asa: solo para la congestión · no cambian la mortalidad

Betabloqueantes en la FE reducida: no todos sirven

✅ **Bisoprolol** · **Carvedilol** · **Metoprolol succinato**
✅ **Nebivolol** (en mayores de 70 años)

❌ Atenolol · Propranolol · Metoprolol tartrato
No demostraron bajar la mortalidad en la IC.

💡 **PARA RECORDAR:** los cuatro pilares son **«A-B-M-S»**: ARNI (o IECA/ARA II), Betabloqueante, antagonista Mineralocorticoide y SGLT2. Si una opción ya trae dos, la respuesta son los otros dos.

Si el paciente sigue con síntomas...	Se agrega	Qué aporta
FC ≥ 70 lpm en ritmo sinusal pese al betabloqueante	**Ivabradina**	Menos internaciones
Afrodescendiente, o no tolera IECA/ARA II	**Hidralazina + nitrato**	Baja mortalidad en ese grupo
Síntomas persistentes o fibrilación auricular	**Digoxina**	Menos internaciones, **no** menos mortalidad
FE ≤ 35 % con bloqueo de rama izquierda ancho	**Resincronizador**	Mejora síntomas y sobrevida
FE ≤ 35 %, o arritmia ventricular o muerte súbita recuperada	**Cardiodesfibrilador**	Previene la muerte súbita

⚠️ **NO SE INDICAN CON FE REDUCIDA:** **verapamilo y diltiazem** (deprimen la contractilidad), **AINE** y **glitazonas** (retienen sodio). La **amiodarona** controla arritmias pero no baja la mortalidad.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** dos formatos. Uno **teórico**: «el betabloqueante indicado...» (2019) o «el fármaco que demostró reducir la mortalidad...» (2026 🔁), con cuatro opciones de las que solo una es de los pilares. Otro **de caso**: te listan todo lo que el paciente ya toma y preguntan qué agregar (2024). Leé la lista: **la respuesta es el pilar que falta**.

1.2.4 FE PRESERVADA Y SIGNOS CLÍNICOS

En la FE preservada el ventrículo **bombea bien pero se llena mal**, porque está engrosado y rígido. La causa más frecuente es la **hipertensión arterial crónica**. Se trata la congestión con diuréticos, se controlan la presión y la frecuencia, y los iSGLT2 reducen las internaciones.

La **respiración de Cheyne-Stokes** (fases que crecen, decrecen y hacen pausas) se asocia a la insuficiencia cardíaca con **gasto bajo**; en Neurología también aparece por daño de ambos hemisferios. La **ascitis** es un signo **tardío** de insuficiencia cardíaca.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** enunciados de **una sola línea** que piden «la causa más frecuente» (2025) o «con qué se relaciona casi siempre» (2021). En Cheyne-Stokes ponen **«FE conservada»** como distractor para que confundas gasto bajo con FE baja.

1.2.5 GUÍAS ACTUALES VS. CONAREM

🔬 Lo más actualizado	📝 Lo que refleja el CONAREM	✅ Qué marcar
Las guías europeas (2021, actualizadas en 2023) indican la **terapia cuádruple** desde el inicio.	Sus distractores vienen de libros anteriores a los iSGLT2: **digoxina, amiodarona, xamoterol**.	Cualquiera de los 4 pilares que aparezca.
La FE se divide en reducida (≤ 40 %), **levemente reducida (41–49 %)** y preservada (≥ 50 %).	Solo habla de FE «disminuida» o «conservada».	«Disminuida» = **reducida**.
Los iSGLT2 bajan internaciones y muerte cardiovascular **con cualquier FE, con o sin diabetes**.	Los ubica dentro del tratamiento de la diabetes, frente a metformina, glimepirida y pioglitazona.	Diabético con cardiopatía: **iSGLT2**. La pioglitazona está contraindicada en la IC.

🧠 PONETE A PRUEBA · INSUFICIENCIA CARDÍACA

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2017 · ▮▮▯ Intermedia · Cardiología · 2017MI-16

1. **Las concentraciones circulantes de péptidos natriureticos son auxiliares útiles en el dx de pacientes con insuficiencia cardiaca pero se incrementan falsamente en ciertas circunstancias:**

A) Pacientes obesos
B) Deterioro de la función renal
C) Infecciones pulmonares
D) Insuficiencia hepática
E) Adultos jóvenes

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2025 · ▮▮▯ Intermedia · Cardiología · 2025B2-46

2. **¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada?**

A) Miocardiopatía dilatada
B) Enfermedad coronaria
C) Amiloidosis cardíaca
D) Hipertensión arterial crónica

MEDICINA INTERNA | CONAREM 2024 | ▮▯▯ Básica | Cardiología | 2024B2-25

3. **Paciente de 65 años de edad, portador Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia mixta, cardiopatía isquémica e hipertensiva. En tratamiento con Insulina glargina, enalapril, atorvastatina, nevibolol. ¿Qué medicación indicaría para disminuir el riesgo cardiovascular del paciente?**

A) Metformina
B) Glimepiride
C) Pioglitazona
D) Empaglifozina
E) Miglitol

1.3 Vasos, tromboembolismo pulmonar y shock

7 preguntas (2016, 2017, 2021, 2022 y 2024). Mezcla tres temas que el examen pregunta de forma muy concreta: **reconocer el tipo de shock**, el TEP y las enfermedades de la aorta y las arterias periféricas.

1.3.1 SHOCK: RECONOCER EL TIPO

El shock es la falla de la perfusión de los tejidos. Antes que el laboratorio, lo muestran tres «ventanas» del examen físico: el **cerebro** (confusión, somnolencia), el **riñón** (diuresis menor de 0,5 mL/kg/h) y la **piel** (fría, moteada, con relleno capilar lento). El lactato mayor de 2 mmol/L lo confirma.

Tipo	Mecanismo	Causas típicas	Perfil
Hipovolémico	Falta volumen	Hemorragia, diarrea, quemaduras	Precarga baja, resistencias altas
Cardiogénico	Falla la bomba	IAM extenso, miocarditis, arritmias	Presión venosa alta, gasto bajo
Obstructivo	Algo impide el llenado o la eyección	**TEP masivo**, taponamiento, neumotórax a tensión	Presión venosa alta, gasto bajo
Distributivo	Vasodilatación	Sepsis, anafilaxia, lesión medular	Resistencias bajas, piel caliente al inicio

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** casos breves para **ponerle nombre al shock** (2022): paciente encamada por fractura de cadera, sin profilaxis, con disnea brusca, hipotensión y dímero D altísimo. Las cinco opciones son los tipos de shock: la pista de la causa (TEP) define la respuesta. También preguntan en teoría cuáles son las «ventanas» (2022).

1.3.2 TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

Se sospecha con disnea brusca, dolor pleurítico, taquicardia y un factor de riesgo (inmovilización, cirugía, cáncer, anticonceptivos). Con probabilidad baja o intermedia, un **dímero D** normal lo descarta; con probabilidad alta o dímero positivo, se confirma con **angiotomografía pulmonar**.

El ecocardiograma no hace el diagnóstico, pero muestra el impacto en el **ventrículo derecho**: dilatación e **hipocinesia de su pared libre**, a veces con la punta conservada (signo de McConnell). Si hay shock, es un TEP de alto riesgo y se indica **trombólisis**.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** pregunta teórica sobre el **signo ecocardiográfico indirecto** (2016). Los distractores cambian el ventrículo (izquierdo por derecho) o ponen hallazgos de otras cardiopatías: aurícula izquierda grande, septo hipertrófico.

1.3.3 ANEURISMAS DE AORTA Y ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA

	Aorta abdominal	Aorta torácica
Causa principal	**Aterosclerosis** (90 %)	Degeneración de la media (Marfan, Ehlers-Danlos), aortitis, aterosclerosis
Paciente típico	Varón mayor de 65 años, fumador	Joven con enfermedad del tejido conectivo, o con vasculitis
Dato de examen	Se opera con ≥ 5,5 cm (≥ 5,0 en mujeres) o si crece más de 1 cm/año	La **arteritis de células gigantes** lo hace unas 18 veces más frecuente

En la **enfermedad arterial periférica**, la claudicación intermitente (dolor en la pantorrilla al caminar que cede con el reposo) se confirma con el **índice tobillo-brazo**. Estos pacientes tienen un riesgo muy alto de morir por infarto o ACV, así que el tratamiento incluye antiagregación, estatina, dejar de fumar y ejercicio supervisado.

Índice tobillo-brazo	Interpretación
1,0 – 1,4	Normal
< 0,9	**Enfermedad arterial periférica**
< 0,4	Isquemia crítica
> 1,4	Arterias calcificadas que no se comprimen (diabetes, enfermedad renal): no es normal

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** casos clínicos con la pregunta «¿cuál es correcto?» (2022), donde las falsas niegan lo importante: que el paciente «no» tiene más riesgo cardiovascular, que los antiagregantes «no» sirven, o que el primer estudio es una angiorresonancia. Y una pregunta difícil de dato puro (2024): qué enfermedad multiplica por 18 el riesgo de aneurisma torácico, entre cinco vasculitis.

1.3.4 TROMBOSIS VENOSA DEL MIEMBRO SUPERIOR

A diferencia de la de las piernas, casi siempre tiene una causa local: **catéteres venosos centrales, cables de marcapasos o cardiodesfibriladores**, cáncer, o compresión en la salida torácica por esfuerzo repetido (síndrome de Paget-Schroetter).

> 📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** lista de factores de riesgo de trombosis (2021) donde casi todos son reales pero de la **pierna** (cirugía de cadera, cirugía oncológica, internación). La pista está en «extremidad superior»: **marcapasos**.

1.3.5 GUÍAS ACTUALES VS. CONAREM

🔬 Lo más actualizado	📝 Lo que refleja el CONAREM	✅ Qué marcar
El shock se confirma con hipotensión e **hiperlactatemia** (> 2 mmol/L); en la sepsis es el criterio de Sepsis-3.	Pregunta el reconocimiento clínico y las «ventanas».	Cerebro, riñón y piel.
Un índice tobillo-brazo **> 1,4** no es normal: indica arterias calcificadas.	Pide el valor que **corrobora** la enfermedad.	Menor de 0,9: un valor de 0,7 la confirma.

🧠 PONETE A PRUEBA · VASOS, TEP Y SHOCK

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2022 · ▮▯▯ Básica · Cardiología · 2022B2-26

1. Usted evalúa a una paciente de 70 años de edad, con fractura de cadera, encamada, sin profilaxis para trombosis venosa profunda, que presenta disnea brusca, taquicardia, taquipnea y que la presión arterial cae por debajo de 80-40mmHg, con un dinero D por encima de 5000ug/ml. Ante esta situación clínica, se plantea el diagnóstico de:

A) Shock distributivo
B) Shock cardiogénico
C) Shock hipovolémico
D) Shock obstructivo
E) Shock anafiláctico

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2022 · ▮▮▯ Intermedia · Cardiología · 2022B2-03

2. Acude a la consulta paciente varón de 60 años por historia de claudicación a nivel de las pantorrillas al caminar 150 metros; el paciente es hipertenso y fumador de larga data. Al examen físico ambos pulsos pedios y tibiales posteriores son débiles. Con su sospecha diagnostica, ¿cuál de los siguientes enunciados les correcto?:

A) El paciente no presenta un riesgo aumentado de muerte de cardiopatía isquémica en comparación a la población general
B) La angiografía por resonancia magnética debe ser el primer estudio a solicitar
C) Un índice tobillo-brazo de 0,7 corrobora el diagnóstico
D) Agregar antiagregantes plaquetarios no ofrece ningún beneficio
E) La Amlodipina debe ser el fármaco inicial para tratamiento

MEDICINA INTERNA | CONAREM 2024 | ▮▮▮ Difícil | Cardiología | 2024B2-22

3. Del siguiente listado de condiciones patológicas, tienen una posibilidad 18 veces mayor que la población general de presentar aneurisma de la aorta torácica los pacientes afectados por:

A) Poliangitis microscópica
B) Granulomatosis con poliangitis
C) Vasculitis por IgA
D) Granulomatosis eosinofílica con poliangitis
E) Arteritis de células gigantes

1.4 Válvulas, endocarditis y miocardio

6 preguntas, concentradas en 2016, 2017 y 2019. Dos ejes: **a quién dar profilaxis de endocarditis** y las miocardiopatías, con un tema que en Paraguay no puede faltar: **Chagas**.

1.4.1 PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA

Se indica solo cuando coinciden un **paciente de alto riesgo** y un **procedimiento de riesgo**: los dentales que manipulan la encía o la región periapical, o perforan la mucosa. No se indica en procedimientos digestivos ni urinarios de rutina.

✅ Alto riesgo: sí profilaxis	❌ No necesitan profilaxis
Prótesis valvular o material protésico de reparación	**Prolapso mitral aislado**
Endocarditis previa	Valvulopatías nativas sin endocarditis previa
Cardiopatía congénita cianótica, o reparada con material protésico	Comunicación interauricular aislada
Trasplante cardíaco con valvulopatía	Marcapasos o cardiodesfibrilador

Situación	Fármaco · 30 a 60 minutos antes
Sin alergia	**Amoxicilina 2 g** vía oral
Alérgico a la penicilina	**Azitromicina o claritromicina 500 mg**, o doxiciclina 100 mg

💡 **PARA RECORDAR:** la indicación la da **el paciente**, no la válvula: un prolapso mitral que ya tuvo endocarditis entra por «endocarditis previa».

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** dos preguntas en el mismo examen (2017). Un caso: joven con prolapso mitral y una endocarditis hace 2 años, con opciones que generalizan («los betabloqueantes **siempre**», «la reparación en **todos**»). Y una teórica: el antibiótico para el alérgico a la penicilina, frente a amoxicilina, ciprofloxacina, metronidazol y vancomicina.

1.4.2 INSUFICIENCIA AÓRTICA AGUDA

Aparece de golpe por **endocarditis** o **disección aórtica**. El ventrículo no tiene tiempo de adaptarse y el paciente cae en edema agudo de pulmón o shock. El tratamiento es la **cirugía urgente**; mientras tanto, vasodilatadores (nitroprusiato) e inotrópicos.

⚠️ **TRAMPA:** los **betabloqueantes están contraindicados**: la taquicardia acorta la diástole, que es cuando la sangre regurgita. Si se frena el corazón, la diástole se alarga y la regurgitación empeora.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** pregunta corta (2019): «¿qué droga está contraindicada?». Los distractores son fármacos que sí se pueden usar (diuréticos, nitroprusiato) o que no vienen al caso (anticoagulantes).

1.4.3 MIOCARDIOPATÍAS

	Qué la caracteriza	Lo que preguntan
Chagas (*Trypanosoma cruzi*)	Endémica en Paraguay. Miocardiopatía dilatada años después de la infección	**Disfunción del nodo sinusal**, bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo, aneurisma de la punta, arritmias ventriculares y embolias
Hipertrófica	Herencia autosómica dominante; septo engrosado que puede obstruir la salida del VI	Muerte súbita en jóvenes deportistas. Con factores de riesgo: **cardiodesfibrilador**
Miocarditis viral	Coxsackie B es la causa clásica	Si es por **virus de la hepatitis C**, puede mejorar con interferón

⚠️ **TRAMPA:** en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva empeoran la obstrucción los **vasodilatadores, los diuréticos en exceso y la digoxina**. Los síntomas se tratan con betabloqueantes o verapamilo, pero eso **no** previene la muerte súbita: solo el cardiodesfibrilador.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** preguntas de dato concreto en un solo examen (2016): la manifestación típica de Chagas entre otras cardiopatías, el tratamiento que evita la muerte súbita en la hipertrófica (frente a betabloqueantes, verapamilo, amiodarona) y una difícil sobre qué virus responde al interferón.

1.4.4 GUÍAS ACTUALES VS. CONAREM

🔬 Lo más actualizado	📝 Lo que refleja el CONAREM	✅ Qué marcar
Las guías de la AHA (2021) **sacaron la clindamicina** de la profilaxis; las europeas (2023) suman a los pacientes con válvula percutánea (TAVI) y asistencia ventricular.	Mantiene la respuesta clásica para el alérgico: un **macrólido**.	Claritromicina o azitromicina.
La hepatitis C hoy se trata con **antivirales de acción directa**: el interferón está prácticamente en desuso.	Pregunta según el texto clásico.	Virus de la hepatitis C → interferón.

🧠 PONETE A PRUEBA · VÁLVULAS Y MIOCARDIO

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2016 · ▮▮▯ Intermedia · Cardiología · 2016MI-17

1. Una de las manifestaciones cardiacas típicas de la enfermedad de Chagas es:

A) Disfunción del nodo sinusal
B) Síndrome coronario agudo
C) Prolapso de la válvula mitral
D) Hipertrofia ventricular izquierda
E) Endocarditis subaguda

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2019 · ▮▮▯ Intermedia · Cardiología · 2019MI-08

2. En una paciente con insuficiencia aortica aguda. ¿Qué droga esta contraindicada?

A) Diuréticos
B) Nitroprusiato de sodio
C) Anticoagulantes orales
D) Betabloqueantes

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2017 · ▮▮▯ Intermedia · Cardiología · 2017MI-17

3. Acude a la consulta paciente joven de 30 años portador de prolapso de valvula mitral, con antecedentes de haber presentado una endocarditis infecciosa hace 2 años. Cual es su conducta?

A) Esta indicada la profilaxis para endocarditis infecciosa para pacientes con antecedentes de endocarditis
B) Los B-bloq siempre están indicados en pacientes con prolapso de la valvula mitral
C) El tto con AAS siempre esta indicado
D) La reparación de la valvula mitral esta indicada en todos los pacientes con prolapso de la valvula mitral

1.5 Cardiopatía isquémica

5 preguntas (2018, 2021, 2023 y 2024). Lo que más pregunta: **ubicar el infarto en el ECG**, cuándo fibrinolizar, cuánto dura la doble antiagregación y una entidad que imita al infarto: **Takotsubo**.

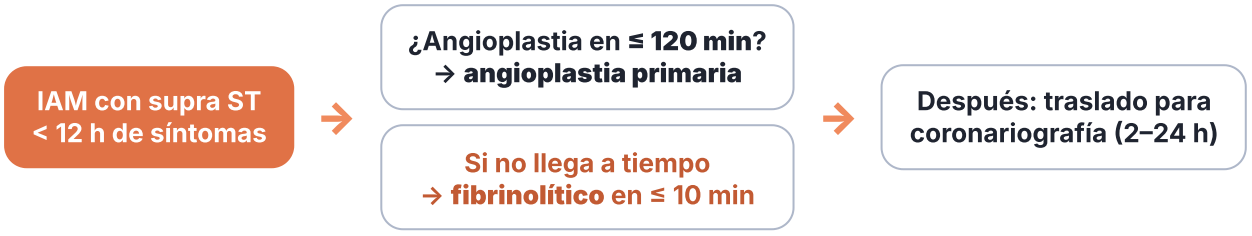
1.5.1 UBICAR EL INFARTO EN EL ECG

Cara	Derivaciones con supradesnivel	Arteria más probable
Inferior (diafragmática)	**DII, DIII, aVF**	Coronaria derecha
Anterior	V1 – V4	Descendente anterior
Anterior extensa	V1 – V6, DI, aVL	Descendente anterior proximal
Lateral	DI, aVL, V5, V6	Circunfleja
Posterior	**Infradesnivel** V1–V3 con R alta (supra en V7–V9)	Circunfleja o coronaria derecha
Ventrículo derecho	V3R – V4R	Coronaria derecha proximal

⚠️ **TRAMPA:** en el infarto **inferior**, buscá compromiso del ventrículo derecho (hipotensión, yugulares ingurgitadas, pulmones limpios). Ahí se dan **volumen** y se evitan nitratos, morfina y diuréticos, porque el VD depende de la precarga.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** caso clínico (2021): mujer con disnea, sudoración y dolor epigástrico, con supradesnivel en DII, DIII y aVF. Las opciones combinan nombres de caras que suenan parecido: «lateral inferior», «lateral alta», «posterior». Ojo: el examen dice **«diafragmática»** en vez de inferior.

1.5.2 REPERFUSIÓN EN EL IAM CON SUPRADESNIVEL DEL ST



Contraindicaciones absolutas de la fibrinólisis
ACV hemorrágico previo, o isquémico en los últimos 6 meses · Tumor o malformación del sistema nervioso central · Traumatismo, cirugía o lesión craneal mayor reciente · Sangrado activo · Disección aórtica

La reperfusión fue exitosa si en 60 a 90 minutos el ST desciende **más del 50 %**, cede el dolor y aparecen arritmias de reperfusión (ritmo idioventricular acelerado).

> 📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** caso de un IAM anterior extenso (2018) en el que la hemodinamia recién estaría disponible en 24 horas. Las opciones incorrectas **esperan**: reevaluar en 12 horas, aguardar al hemodinamista o «tratamiento conservador» con atenolol. Si la angioplastia no llega a tiempo, la respuesta es **fibrinolizar de entrada**.

1.5.3 DESPUÉS DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Con stent, la **doble antiagregación** (aspirina más un inhibidor P2Y12: ticagrelor o prasugrel, o clopidogrel si no se pueden usar) se mantiene **12 meses**. Además: estatina de alta intensidad, betabloqueante, IECA y rehabilitación cardíaca.

Para diagnosticar coronariopatía crónica en pacientes de probabilidad baja o intermedia, la **angiotomografía coronaria** es el estudio no invasivo con mayor sensibilidad y especificidad: si es normal, prácticamente la descarta. La coronariografía invasiva sigue siendo el patrón de oro.

> 📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** preguntas de **número exacto**: «el tiempo de doble antiagregación… es de cuando menos» (2024), con opciones de 1, 3, 6, 9 y 12 meses. Y una difícil de comparación de estudios (2023), entre eco de esfuerzo, eco con dobutamina, PET y resonancia.

1.5.4 MIOCARDIOPATÍA DE TAKOTSUBO

Típica de la **mujer posmenopáusica** después de un estrés emocional o físico fuerte. Imita un infarto (dolor, cambios del ST, troponina elevada), pero las **coronarias no tienen lesiones**. El ventrículo izquierdo se abomba en la punta (en japonés, *takotsubo* es la vasija para atrapar pulpos) y **se recupera en días o semanas**. El tratamiento es de sostén.

> 📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** «marque lo correcto» (2023) con distractores que contradicen cada rasgo: «más común en varones jóvenes», «enfermedad de múltiples vasos», «angioplastia de urgencia», «la diabetes es el factor de riesgo más importante».

1.5.5 GUÍAS ACTUALES VS. CONAREM

🔬 Lo más actualizado	📝 Lo que refleja el CONAREM	✅ Qué marcar
Las guías europeas (2023) permiten **acortar la doble antiagregación** a 1–3 meses si hay alto riesgo de sangrado.	Pregunta el tiempo «cuando menos» en el paciente estándar.	**12 meses**.
Si no hay angioplastia en 120 minutos, fibrinolítico y luego traslado para coronariografía en 2 a 24 horas (estrategia farmacoinvasiva).	Plantea demoras de muchas horas.	**Fibrinolítico de entrada**, nunca esperar.

🧠 PONETE A PRUEBA · CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2018 · ▮▮▯ Intermedia · Cardiología · 2018MI-04

1. **Paciente masculino, 54 años de edad, dislipidemico y tabaquista. Ingresa a la urgencia por dolor de pecho retroesternal de 2horas de evolución. Presión arterial 130-70mmHg. ECG con marcada elevación de ST de V1 a V6. Troponina I y enzimas cardiacas elevadas. Cual opción es la que aporta mayores beneficios para la recuperación del paciente?**

A) Administrar aspirina, clopidrogrel, nitratos sublinguales y reevaluar en 12 horas.
B) Administrar tratamiento fibrinolitico de entrada
C) Esperar 24 horas para que este disponible el equipo de hemodinamia y someterlo a angioplastia primaria
D) Administrar aspirina, morfina, atenolol, oxigenoterapia y optar por tratamiento conservador

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2021 · ▮▯▯ Básica · Cardiología · 2021B2-03

2. **Paciente de 60 años de edad, de sexo femenino, que en reposo presenta disnea de inicio brusco, con sudoración profusa, acompañado de dolor en epigastrio. Evaluada en la sala de urgencias, 3 horas después del inicio de los síntomas referidos, se le practica un electrocardiograma encontrándose supra desnivel en las derivaciones DII, DITI, AVF, el médico realiza el diagnostico de:**

A) Infarto agudo de miocardio de cara diafragmática
B) Infarto agudo de miocardio de cara lateral inferior
C) Infarto agudo de miocardio de cara lateral alta
D) Infarto agudo de miocardio de cara anterior
E) Infarto agudo de miocardio de cara posterior

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2023 · ▮▯▯ Básica · Cardiología · 2023B2-12

3. **Marque lo correcto sobre la miocardiopatía de Takotsubo:**

A) Es más común en varones jóvenes sanos
B) Ocurre por enfermedad de múltiples vasos coronarios
C) La angioplastia coronaria de urgencia es el tratamiento de elección
D) La diabetes mellitus es el factor de riesgo más importante para su aparición
E) La disfunción ventricular por lo general se resuelve en días a semanas

1.6 Hipertensión arterial

5 preguntas (2018, 2020, 2021 y 2024). El examen no pregunta cifras de diagnóstico: pregunta **qué antihipertensivo elegir según el paciente** y cuándo sospechar una **hipertensión secundaria**.

1.6.1 ELEGIR EL FÁRMACO SEGÚN EL PACIENTE

Las cinco familias de primera línea son IECA, ARA II, bloqueantes de calcio, tiazidas y, en situaciones específicas, betabloqueantes. La comorbilidad decide cuál conviene y cuál está prohibida.

Paciente	✅ Preferir	❌ Evitar
Diabético con albuminuria	IECA o ARA II (protegen el riñón)	—
Embarazada	**Labetalol**, nifedipina, metildopa	IECA, ARA II, espironolactona (dañan al feto)
Asmático	Bloqueantes de calcio, IECA, tiazidas	**Betabloqueantes no selectivos**
Insuficiencia cardíaca o post-infarto	IECA/ARNI, betabloqueante, espironolactona	Verapamilo, diltiazem
Gota	Losartán (baja el ácido úrico)	Tiazidas y diuréticos de asa
Hiperplasia prostática	Alfabloqueantes	—
Estenosis bilateral de arterias renales	Bloqueantes de calcio	IECA y ARA II

💡 **PARA RECORDAR:** en el asma, el problema son los betabloqueantes que bloquean β2 (propranolol, nadolol, carvedilol, labetalol). Los cardioselectivos (bisoprolol, metoprolol, nebivolol) se pueden usar con precaución si el asma está controlada.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** casos breves con una comorbilidad que define todo: el diabético con albuminuria creciente (2021), la embarazada de 12 semanas con 166/94 (2024) o el asmático hipertenso (2018). En el embarazo, las trampas son **dos IECA** (lisinopril y enalapril) y la espironolactona; en el asma preguntan el grupo contraindicado.

1.6.2 HIPERTENSIÓN SECUNDARIA

Se sospecha en el **joven (menor de 30 años)**, en la hipertensión resistente a tres fármacos, en la de inicio brusco o con hipopotasemia espontánea.

Causa	Pista clínica	Cómo se confirma
Estenosis de la arteria renal	**La creatinina sube más del 30 % al iniciar un IECA**; soplo abdominal; riñones asimétricos. Mujer joven: displasia fibromuscular; mayor: aterosclerosis	Eco Doppler, angiotomografía
Coartación de aorta	Causa congénita más frecuente. PA alta en los brazos, pulsos femorales débiles, muescas costales	Ecocardiograma, angiotomografía
Hiperaldosteronismo primario	Hipopotasemia, alcalosis metabólica	Cociente aldosterona/renina
Feocromocitoma	Crisis de cefalea, sudoración y palpitaciones	Metanefrinas en plasma u orina
Otras	Apnea del sueño, Cushing, hipertiroidismo, enfermedad renal	Según la sospecha

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** caso que da **una sola pista** (2018): joven de 24 años con enalapril cuyas urea y creatinina suben a las 2 semanas. Las opciones son cinco causas de HTA secundaria; solo una se relaciona con el IECA. Y una teórica de una línea (2020): la causa cardiovascular **congénita** más frecuente, frente a cardiopatías congénitas que no dan hipertensión.

1.6.3 GUÍAS ACTUALES VS. CONAREM

🔬 Lo más actualizado	📝 Lo que refleja el CONAREM	✅ Qué marcar
Desde 2022, el colegio estadounidense de obstetras recomienda tratar la hipertensión crónica del embarazo desde **140/90**.	Plantea cifras de 160/90 o más, que siempre se tratan.	**Labetalol**; nunca IECA ni ARA II.
Los betabloqueantes **cardioselectivos** se pueden usar en el asma controlada.	Pregunta por el **grupo** «betabloqueantes».	Si la opción dice «betabloqueantes», es la contraindicada.

🧠 PONETE A PRUEBA · HIPERTENSIÓN ARTERIAL

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2018 · ▮▮▯ Intermedia · Cardiología · 2018MI-02

1. Paciente joven de 24 años de edad, con hipertensión arterial secundaria, medicado con enalapril 10mg vía oral cada 12 horas. A las 2 semanas en control de análisis laboratorial se constata aumento de las cifras de urea y creatinina. La causa de hipertensión arterial secundaria es:

A) Feocromocitoma
B) Coartacion de la aorta
C) Hiperaldosteronismo primario
D) Estenosis de la arteria renal
E) Enfermadad de Cushing

MEDICINA INTERNA · CONAREM 2024 · ▮▯▯ Básica · Cardiología · 2024B2-11

2. Mujer de 35 años con 12 semanas de gestación, asintomática, sin enfermedad cardiovascular conocida ni controles previos de presión. Se constata PA 166/94 mmHg y en el siguiente control 162/90 mmHg; glucosa, creatinina y orina normales. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado?

A) Solamente dieta y cambios del estilo de vida
B) Labetalol
C) Lisinopril
D) Enalapril
E) Espironolactona

MEDICINA INTERNA | CONAREM 2018 | ▮▯▯ Básica | Cardiología | 2018MI-06

3. En personas con asma e hipertensión arterial. Cual de los siguientes grupos farmacológicos antihipertensivos tiene contraindicación para su uso?

A) Beta bloqueantes
B) IECA
C) Bloqueadores de calcio
D) Diuréticos tiazidicos
E) Alfa bloqueantes

1.7 Pericardio

4 preguntas (2016, 2017, 2022 y 2024), con una que **se repitió**: la pericarditis del paciente urémico. El examen pregunta sobre todo **la conducta** según la causa.

1.7.1 PERICARDITIS AGUDA

Se diagnostica con **2 de estos 4 criterios**: dolor torácico que empeora al inspirar y acostado y mejora sentado e inclinado hacia adelante; frote pericárdico; supradesnivel del ST difuso y cóncavo con infradesnivel del PR; derrame pericárdico nuevo.

Tratamiento	Dosis habitual	Duración
AINE o aspirina	Ibuprofeno 600 mg c/8 h o aspirina 750–1000 mg c/8 h	1–2 semanas, con descenso
+ Colchicina	0,5 mg c/12 h (c/24 h si pesa menos de 70 kg)	3 meses; 6 si es recurrencia
Corticoides	Solo si lo anterior falla o está contraindicado	Aumentan las recurrencias

💡 **PARA RECORDAR:** la colchicina **reduce las recurrencias a la mitad**. Los corticoides parecen una buena idea pero **aumentan** las recurrencias: quedan como última opción.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** pregunta de una línea (2022): «ayuda a reducir el riesgo de pericarditis recurrente...», con prednisona, indometacina e inmunoglobulina como distractores.

1.7.2 PERICARDITIS URÉMICA

Aparece en la enfermedad renal avanzada por acumulación de toxinas urémicas. Es una **indicación de diálisis urgente**: la diálisis trata la causa. Los AINE, la colchicina y los corticoides funcionan poco, y si el paciente ya se dializa se intensifican las sesiones. La punción queda para el taponamiento.

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** **la misma pregunta en 2016 y 2024** 🔁: un caso de insuficiencia renal crónica con pericarditis por ecocardiograma y «el tratamiento de elección es...». Las opciones son los tratamientos de la pericarditis común (prednisona, aspirina, colchicina), más punción, heparina o furosemida.

1.7.3 DERRAME PERICÁRDICO Y TAPONAMIENTO

La causa más frecuente de pericarditis es viral o idiopática, pero en países como Paraguay hay que pensar en **tuberculosis**: una **adenosina desaminasa (ADA) de 40 U/L o más** en el líquido pericárdico la sugiere fuertemente. Otras causas: urémica, neoplásica, post-infarto, autoinmune e hipotiroidismo.

Taponamiento cardíaco: cómo reconocerlo
Tríada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados · **pulso paradójico** (la PA sistólica cae más de 10 mmHg al inspirar) · complejos QRS de voltaje alternante · Tratamiento: **pericardiocentesis**

📝 **CÓMO LO PREGUNTA EL CONAREM:** caso (2017) de un etilista con derrame pericárdico y ADA de 50 U/L en el líquido, y preguntan **el paso siguiente**. Las trampas son tratar sin diagnóstico: drenar, aspirina, prednisona, o pedir hormonas tiroideas.

1.7.4 GUÍAS ACTUALES VS. CONAREM

🔬 Lo más actualizado	📝 Lo que refleja el CONAREM	✅ Qué marcar
Las guías europeas usan colchicina **ajustada al peso y sin dosis de carga**, junto con el AINE desde el primer episodio.	Pregunta qué **reduce las recurrencias**.	**Colchicina**, no prednisona.
En la pericarditis de un paciente que ya se dializa, se intensifica la diálisis.	Presenta al paciente urémico sin diálisis.	**Diálisis de urgencia**.

🧠 PONETE A PRUEBA · PERICARDIO

MEDICINA INTERNA | CONAREM 2016 | ▮▮▯ Intermedia | Cardiología | 2016MI-15

1. **Paciente varón de 56 años, portador de insuficiencia renal crónica desde hace 6 años, secundario a hipertensión arterial, tratado con Amlodipina, carbonato de calcio, eritropoyetina. Ultima tasa de Filtracion Glomerular de 18 ml/min por 1.73 m2 que se realizó dos semanas antes a la consulta. Diuresis diaria de 1600 ml. Acude por dolor de pecho. Se realiza electrocardiograma dentro de la normalidad y enzimas cardiacas seriadas negativas. La ecocardiografía presenta signos de pericarditis aguda, la cual se interpreta como una pericarditis urémica, motilidad de las paredes cardiacas normales. La conducta más apropiada para este paciente es:**

A) Prednisona 50 mg día
B) Ácido acetil salicílico 1 gramo cada 6 horas
C) Colchicina 1 mg día
D) Iniciar en forma urgente hemodiálisis
E) Iniciar trimetazidina

MEDICINA INTERNA | CONAREM 2017 | ▮▮▯ Intermedia | Cardiología | 2017MI-15

2. **Paciente de 45 años sin antecedentes patológicos personales, etilista crónico, se encuentra en su segundo día de internación por historia compatible de pericarditis aguda, por ecocardiografía se constata derrame pericárdico moderado, sin signos de taponamiento, se procede a pericardiocentesis, cuyo estudio mas relevante es el dosaje de desaminasa de adenosina de 50U/L. Su conducta mas adecuada con este paciente seria:**

A) Colocación de un tubo de drenaje pericárdico
B) Iniciar AAS 4 gr/día
C) Iniciar prednisona 100mg/día
D) Solicitar estudio para mycobacterium TB
E) Solicitar dosaje de hormonas tiroideas

MEDICINA INTERNA | CONAREM 2022 | ▮▯▯ Básica | Cardiología | 2022B2-02

3. **Ayuda a reducir el riesgo de pericarditis recurrente el uso de:**

A) Prednisona
B) Colchicina
C) Inmunoglobulina
D) Indometacina

LAS OTRAS 9 SUBESPECIALIDADES

Vista previa: de qué preguntan

Los temas de cada subespecialidad, cuántas preguntas tuvo cada uno y lo que se repitió. El desarrollo completo, con cada pregunta comentada, está en AranduMed.

🔒 Las 9 subespecialidades completas en AranduMed · Probalo gratis →

Endocrinología y diabetes

45 preguntas

- **Suprarrenal (14):** signos más específicos de Cushing, cómo confirmarlo y ubicar la causa, insuficiencia primaria vs secundaria, feocromocitoma.
- **Diabetes y obesidad (13):** qué hace cada antidiabético, cuál sube o baja de peso, qué elegir en el cardiópata, cetoacidosis.
- **Hipófisis, calcio, hueso y lípidos (10):** Sheehan, prolactina, hipocalcemia, osteoporosis, clasificación de Fredrickson.
- **Tiroides (8):** Graves, nódulo con calcitonina alta, TSH en la embarazada, hipotiroidismo congénito.

🔁 Cushing salió en 6 exámenes distintos.

🔒 Las preguntas, sus respuestas y el resumen completo, en AranduMed

Infectología

45 preguntas

- **Neumonía y sepsis (11):** CURB-65 y PSI, gérmenes según la exposición, tratamiento empírico, procalcitonina.
- **Tropicales, zoonosis y TB (9):** leptospirosis, brucelosis, leishmaniasis, paludismo, cólera, TB en la embarazada.
- **Digestivas (6):** H. pylori, C. difficile, intoxicación alimentaria, S. bovis.
- **Sistema nervioso, ITS e inmunodeprimidos (14):** meningitis y encefalitis, sífilis y cuándo hacer punción lumbar, VIH con CD4 bajo, trasplantados.

🔁 Leptospirosis salió en 2021 y 2024; sífilis, 3 veces.

🔒 Las preguntas, sus respuestas y el resumen completo, en AranduMed

Neurología

33 preguntas

- **Demencias (8):** Alzheimer, vascular, frontotemporal, qué pedir en el laboratorio.
- **Nervios, pares craneales y dolor neuropático (8):** Guillain-Barré, parálisis de Bell, botulismo.
- **ACV (6):** AIT, síndromes lacunares, edema, hemorragia subaracnoidea, escala ABCD2.
- **Epilepsia y cefaleas (9):** ausencias, crisis psicógenas, síncope vs convulsión, migraña.

🔁 Demencia frontotemporal: 3 veces, 2 con las mismas palabras.

🔒 Las preguntas, sus respuestas y el resumen completo, en AranduMed

Neumología

30 preguntas

- **Intersticiales y ocupacionales (7):** sarcoidosis, silicosis, asbesto, fibrosis, eosinofilias.
- **EPOC (6):** GOLD, gravedad por espirometría, corticoides.
- **Asma (6):** escalones de tratamiento, crisis grave en la gasometría, asma por ejercicio.
- **Pleura (5):** exudado vs trasudado, TB pleural, derrame paraneumónico.

🔁 El derrame paraneumónico salió igual en 2022 y 2023.

🔒 **Las preguntas, sus respuestas y el resumen completo, en AranduMed**

Gastroenterología y hepatología

29 preguntas

- **Hígado (15):** hepatitis B, hepatotóxicos, cirrosis y sus complicaciones, Wilson, Budd-Chiari.
- **Intestino (8):** celíaca, colitis ulcerosa, sobrecrecimiento bacteriano, colon irritable.
- **Páncreas (3):** enzima de elección y pruebas de función.
- **Esófago y estómago (3):** acalasia, tumores benignos, inhibidores de la bomba.

🔁 «Efecto tóxico directo sobre el hígado»: 2016 y 2023.

🔒 **Las preguntas, sus respuestas y el resumen completo, en AranduMed**

Nefrología

26 preguntas

- **Lesión renal aguda (7):** prerrenal vs renal, contraste, anuria.
- **Enfermedad renal crónica y diálisis (6):** mieloma, complicaciones de la uremia y de la hemodiálisis.
- **Glomerulopatías (5):** anticuerpos, biopsia y tratamiento.
- **Electrolitos y litiasis (8):** hiponatremia euvolémica, hipercalcemia, cálculos.

🔁 3 preguntas repetidas: contraste, hiponatremia y litiasis.

🔒 **Las preguntas, sus respuestas y el resumen completo, en AranduMed**

Hematología

25 preguntas

- **Anemias y aplasia (9):** ferropenia, déficit de B12, hemólisis, aplasia medular.
- **Hemostasia y anticoagulación (8):** PTT, Von Willebrand, CID, warfarina, heparina, transfusiones.
- **Onco-hematología (8):** leucemias, policitemia vera, mieloma, linfoma de Hodgkin.

🔁 El tratamiento de la PTT salió en 2019 y 2026.

🔒 **Las preguntas, sus respuestas y el resumen completo, en AranduMed**

Reumatología

25 preguntas

- **Artritis reumatoide (7):** tratamiento, embarazo, anticuerpos, hemograma.
- **Vasculitis (6):** Wegener, poliarteritis, arteritis temporal, Takayasu.
- **Otras autoinmunes (8):** antifosfolípido, Sjögren, dermatomiositis, Raynaud, sarcoidosis.
- **Artrosis, gota y espondiloartritis (4):** diagnóstico clínico y manifestaciones extraarticulares.

🔁 La anemia de la artritis reumatoide salió en 2022 y 2024.

🔒 **Las preguntas, sus respuestas y el resumen completo, en AranduMed**

Oncología y cuidados paliativos

8 preguntas

- **Cuidados paliativos y final de la vida (5):** escalera analgésica y opioides, fatiga del paciente avanzado, comunicar malas noticias, definiciones éticas.
- **Urgencias oncológicas (3):** lisis tumoral, compresión medular maligna, derrame pleural neoplásico.

🔁 Cuidados paliativos salió 5 veces, todas entre 2022 y 2024.

🔒 **Las preguntas, sus respuestas y el resumen completo, en AranduMed**

21 PREGUNTAS REALES DEL CONAREM

Matriz de corrección

Marcá tu respuesta en cada fila y después compará con la clave. Así ves qué temas tenés que repasar.

Tema	Pregunta	Tu respuesta	Clave
Arritmias y ECG	1 · 2023	A B C D E	**C**
	2 · 2024	A B C D	**D**
	3 · 2026	A B C	**B**
Insuficiencia cardíaca	1 · 2017	A B C D E	**B**
	2 · 2025	A B C D	**D**
	3 · 2024	A B C D E	**D**
Vasos, TEP y shock	1 · 2022	A B C D E	**D**
	2 · 2022	A B C D E	**C**
	3 · 2024	A B C D E	**E**
Válvulas y miocardio	1 · 2016	A B C D E	**A**
	2 · 2019	A B C D	**D**
	3 · 2017	A B C D	**A**
Cardiopatía isquémica	1 · 2018	A B C D	**B**
	2 · 2021	A B C D E	**A**
	3 · 2023	A B C D E	**E**
Hipertensión arterial	1 · 2018	A B C D E	**D**
	2 · 2024	A B C D E	**B**
	3 · 2018	A B C D E	**A**

Pericardio	1 · 2016	A B C D E	**D**
	2 · 2017	A B C D E	**D**
	3 · 2022	A B C D	**B**

📊 **TU PUNTAJE:** 3 de 3 en un tema: dominado. 2 de 3: repasá el «Cómo lo pregunta el CONAREM». 1 o 0: volvé a leer el tema completo.

¿Querés seguir practicando? Las 1.616 preguntas comentadas, en AranduMed →

YA TENÉS EL MAPA

Ahora practicá con las 1.616 preguntas

En AranduMed están las 313 preguntas de Medicina Interna y las 1.616 de los 11 exámenes, comentadas una por una: la respuesta, por qué, y por qué las otras opciones están mal.

- Plan diario hasta el examen y repasos con el Método Mandu'a
- Simulacros cronometrados como el día del examen
- Tu puesto estimado con los puntajes de 2026

Probalo 3 días gratis →

Tocá acá para crear tu cuenta · incluye los exámenes 2025 y 2026

o entrá a arandumedpy.github.io/CONAREM-PRUEBA · @arandumedpy en Instagram

Próximo volumen: . Seguinos para no perdértelo.